Dolor mixto en enfermedades musculoesqueléticas: cuando el dolor ya no se explica solo por la articulación

Fitzcharles M-A, Deamo Assis R, Polly DW, Cohen SP. Mixed pain phenotypes in musculoskeletal disorders: mechanisms and management. *Nat Rev Rheumatol*. Publicado en línea el 16 de octubre de 2026. doi:10.1038/s41584-026-01443-w

Versión 1.0 · Revisado el 25 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Cambia cómo interpretas el dolor
No trae un tratamiento nuevo; ordena un concepto que explica fracasos terapéuticos.

¿QUÉ TAN SÓLIDA ES LA EVIDENCIA?
Revisión narrativa
Sin búsqueda sistemática declarada; se apoya sobre todo en estudios observacionales y cuestionarios.

LO MÁS ÚTIL PARA LA CONSULTA
Busca el componente nociplástico
Antes de escalar un FARME, infiltrar u operar.

En 30 segundos. El dolor tiene tres mecanismos: nociceptivo, neuropático y nociplástico. En las enfermedades musculoesqueléticas, **más de un tercio** de los pacientes tiene más de uno a la vez ("dolor mixto" o "superpuesto"), casi siempre con un componente nociplástico. Ese componente se asocia a más dolor, peor calidad de vida y peor respuesta a analgésicos, infiltraciones y cirugía. No hay biomarcador: se reconoce con la historia y la exploración. Una vez controlada la enfermedad de base, el manejo debe ser biopsicosocial, con educación, ejercicio, intervenciones psicológicas y fármacos de acción central usados con cautela.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Revisión narrativa vs revisión sistemática. Una revisión narrativa reúne la experiencia y la selección de estudios de sus autores; no declara cómo buscó ni qué excluyó, y no combina datos con método. Sirve para entender un concepto y ordenar el problema, pero sus cifras vienen de estudios distintos, con herramientas distintas, que no se pueden sumar ni comparar directamente.

1 Qué tipo de artículo es y cuánto pesa su evidencia

TIPO	Revisión narrativa por invitación en *Nature Reviews Rheumatology*. Cuatro autores: reumatología, medicina del dolor, cirugía de columna y anestesiología.
MÉTODO DECLARADO	No describe estrategia de búsqueda, criterios de inclusión ni evaluación de calidad. Sus tablas citan revisiones sistemáticas y metaanálisis, pero también estudios transversales y series pequeñas.
BASE DE LAS CIFRAS	Mayormente observacional: cuestionarios (painDETECT, inventario de sensibilización central), pruebas sensoriales cuantitativas y registros. No hay ensayos que comparen estrategias guiadas por fenotipo de dolor.
CONFLICTOS DE INTERÉS	Los autores declaran no tener conflictos. Uno de los revisores externos fue un investigador líder del concepto de dolor nociplástico.
LO QUE SÍ APORTA	Un marco clínico aplicable, una tabla de rasgos para reconocer cada fenotipo y una síntesis de sus consecuencias en procedimientos y cirugía.

2 Cómo se reconoce cada componente

Neuropático superpuesto. Síntomas en un dermatoma o territorio nervioso, dolor lancinante, alodinia focal y debilidad neurológica. Más de 40 % de las radiculopatías afecta varios dermatomas o tiene un patrón aberrante. DATO DEL ARTÍCULO Neuropatía periférica reportada en 28.6 % de pacientes con artritis reumatoide, 7.6 % con lupus y 15 % con enfermedad de Sjögren.

Nociplástico superpuesto. Dolor más intenso, más fluctuante, a menudo sin provocación, con síntomas sensoriales, motores y cognitivos. Pistas en la exploración:

- Alodinia táctil o hiperalgesia mecánica **local y a distancia**; hiperalgesia al frío.
- Sensaciones que persisten tras un estímulo inocuo (hiperpatía).
- **Suma temporal**: el dolor aumenta con estímulos repetidos de baja intensidad, en lugar de disminuir.
- En artritis reumatoide, una diferencia **>7 entre articulaciones dolorosas y tumefactas** sugiere fuertemente un fenotipo nociplástico.

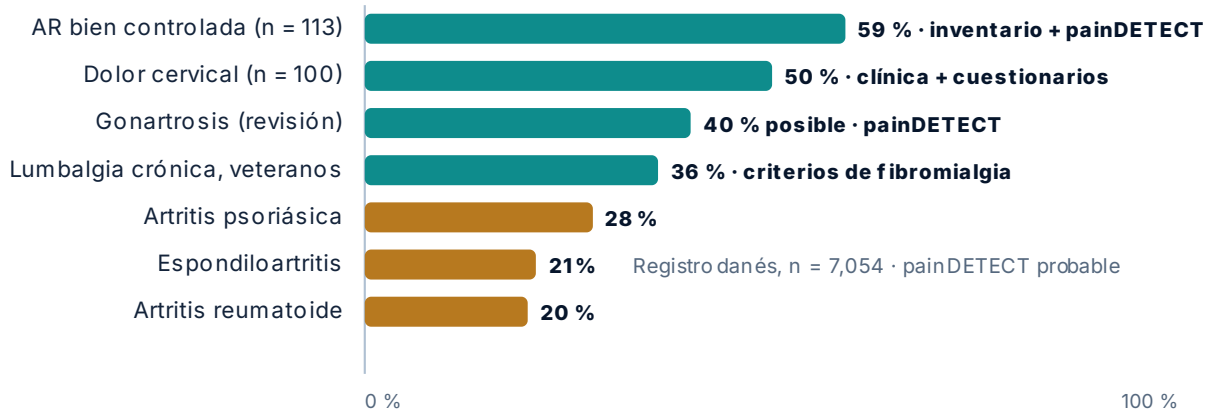
CRITERIOS CLÍNICOS IASP 2021 (PENDIENTES DE VALIDACIÓN)

Posible dolor nociplástico: dolor regional, no discreto, por más de 3 meses, con hipersensibilidad evocada en la exploración.
Probable: además, sensibilidad referida al tacto, presión, movimiento, calor o frío en la zona, junto con comorbilidades como hipervigilancia, sensibilidad a luz, sonido u olores, trastornos del sueño, síntomas gastrointestinales o genitourinarios y dificultades cognitivas sin otra explicación.

EJEMPLO DEL ARTÍCULO: GONARTROSIS

Cambios radiográficos menores, dolor que empeora con ansiedad, disestesias, patrón de dolor difuso y atípico, muchas quejas somáticas y mala respuesta al tratamiento habitual: el componente nociplástico pesa más que la articulación.

3 ¿Qué tan frecuente es?



Esquema elaborado con datos de la tabla 2 y del texto de la revisión. INTERPRETACIÓN Cada barra viene de un estudio, una población y una herramienta distintos (umbrales "posible" vs "probable"); sirven para ver el orden de magnitud, no para comparar enfermedades entre sí.

Otros datos: sensibilización en más de un tercio de las gonartrosis (menos en coxartrosis); umbrales de dolor a la presión anormales en 29 a 77 % de los hombros dolorosos; ansiedad o depresión en ~40 % de los adultos con dolor crónico; tabaquismo asociado a 23 % más riesgo de dolor musculoesquelético crónico (OR 1.23; IC 95 % 1.09–1.40; 32 estudios, 296,109 participantes).

4 Herramientas: útiles para tamizar, no para diagnosticar

HERRAMIENTA	QUÉ APORTA	LÍMITE
Cuestionario de fibromialgia 2011	Indicador de sensibilización central en AR, OA, columna y hombro	Sustituto imperfecto
painDETECT	Diseñado para dolor neuropático (≥19 = probable); puntajes altos sin lesión nerviosa pueden reflejar sensibilización	No separa neuropático de nociplástico
Inventario de sensibilización central	Validez de constructo en muchos tipos de dolor; asociado a peores resultados ortopédicos	Se asoció más a factores psicosociales que a pruebas psicofísicas
COPC-S	Detecta las 10 condiciones de dolor crónico superpuesto; concordancia κ = 0.813 con el médico	Validación reciente
Pruebas sensoriales cuantitativas	Umbral a la presión y suma temporal confiables; aportan la evidencia mecanística	No estandarizadas, lentas, poco reembolsadas
Escala de catastrofización (13 ítems)	Mide rumiación, magnificación e indefensión; fuerte asociación con dolor nociplástico	No mide sensibilización

5 Por qué importa antes de un procedimiento

ESCENARIO	DATO DEL ARTÍCULO
Artroplastia de rodilla (revisión de 2,385 pacientes)	Dolor de tipo neuropático antes de la cirugía (painDETECT ≥13): riesgo de dolor crónico RR 2.75 (IC 1.78–4.26).
Artroplastia de rodilla (>300,000 pacientes)	Fibromialgia concomitante: más complicaciones quirúrgicas, OR 1.55 (IC 95 % 1.51–1.60).
Infiltración epidural por radiculopatía (n = 137)	Con >3 reacciones de "hipersensibilidad" no inmunes en el expediente, el dolor en la pierna bajó en promedio 0.1 puntos, contra 1.8 y 1.6 con 0 y 1–2 reacciones.
Bloqueos de ramo medial y radiofrecuencia	Respuestas aberrantes más frecuentes con fibromialgia; puntajes más altos de fibromialgia predijeron menos alivio tras la ablación.

INTERPRETACIÓN La presencia de dolor nociplástico no contraindica un procedimiento necesario, pero el consentimiento debe incluir expectativas realistas. Los autores señalan que algunas aseguradoras ya listan la sensibilización central como contraindicación, algo que consideran estigmatizante.

6 Qué hacer: el manejo propuesto

1. Controlar la enfermedad de base: FARME en artritis inflamatoria, peso y ejercicio en osteoartritis, fortalecimiento y ejercicio aeróbico en dolor de columna mecánico, terapia física o infiltración guiada en lesiones de tejidos blandos.

2. Si persiste el dolor con fenotipo nociplástico: pasar de lo anatómico a lo biopsicosocial. Educación que fomente autoeficacia; ejercicio dosificado según tolerancia; terapia cognitivo-conductual, de aceptación, mindfulness y manejo del estrés; sueño y hábitos saludables.

DATO DEL ARTÍCULO En un metaanálisis de 249 estudios, todas las modalidades de ejercicio, excepto el estiramiento, mejoraron el dolor y los síntomas de sensibilización. En otro de 13 estudios, la mejoría fue mayor al combinar ejercicio con intervención psicológica.

3. Fármacos con expectativa modesta: tricíclicos, IRSN y ligandos α2δ (gabapentinoides) son los preferidos; los efectos adversos del sistema nervioso central suelen limitar la dosis, y estos pacientes pueden ser más sensibles a ellos.

Opioides: desaconsejados, por el riesgo de hiperalgesia inducida y la menor actividad opioide endógena descrita en sensibilización central.

Emergentes, sin evidencia suficiente: antagonistas NMDA (ketamina, dextrometorfano, memantina, magnesio), N-acetilcisteína, ácido α-lipoico, naltrexona a dosis bajas, estimulación magnética transcraneal y bloqueo del ganglio estrellado.

¿Es reversible? Neuroimagen y pruebas sensoriales sugieren que la sensibilización central es dinámica y modificable; la mejoría en los síntomas reportados es menos consistente.

7 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA O PERMITE CONCLUIR EL ARTÍCULO	ESTADO
Método	Revisión narrativa sin búsqueda sistemática declarada; posible sesgo de selección de estudios.	Limitación del diseño
Medición del fenotipo	Cuestionarios y pruebas que los propios autores consideran de tamizaje; el estándar de referencia es la valoración clínica.	Reconocido por los autores
Evidencia terapéutica	No hay ensayos de tratamiento guiado por fenotipo; las recomendaciones derivan de las de fibromialgia.	Reconocido por los autores
Constructo	Sigue el debate sobre utilidad y límites del dolor nociplástico y su superposición con la somatización.	Reconocido por los autores
Conflictos de interés	Ninguno declarado por los autores.	Confirmado
Aplicabilidad	Las pistas clínicas (dolorosas vs tumefactas, alodinia a distancia, suma temporal, síntomas asociados) no requieren equipo.	Interpretación editorial

POR QUÉ SE PASA POR ALTO EL DOLOR NOCIPLÁSTICO (RECUADRO 1 DEL ARTÍCULO)

Poca formación en mecanismos de dolor; dudas sobre su validez; falta de tiempo; más confianza en la imagen que en la historia clínica; incentivos hacia procedimientos; comorbilidad psiquiátrica y muchos síntomas somáticos; medicalización y tratamientos pasivos; expectativas irreales de alivio total.

Pregunta de repaso: en un registro, 20 % de los pacientes con artritis reumatoide y 28 % con artritis psoriásica tuvieron puntaje "probable" en painDETECT. ¿Significa que 1 de cada 5 tiene neuropatía?

Respuesta. No. painDETECT se diseñó para dolor neuropático, pero sin una lesión nerviosa demostrable un puntaje alto también puede reflejar sensibilización central. Es un tamizaje: indica que una proporción importante tiene un componente no nociceptivo, no cuál, y no sustituye la exploración.

¿Qué aprendí de medicina?

- Más de un tercio de los pacientes musculoesqueléticos tiene **dolor mixto**.
- En AR, dolorosas > tumefactas por más de 7 es una pista fuerte de dolor nociplástico.
- Primero se controla la enfermedad; si persiste el dolor, el manejo pasa a ser biopsicosocial.
- Con componente nociplástico, cirugías e infiltraciones rinden menos: hay que decirlo antes.

¿Qué aprendí de investigación?

- Una revisión narrativa ordena un concepto, pero **no pondera la evidencia**.
- Cifras de estudios y herramientas distintas no se comparan entre sí.
- Un cuestionario de tamizaje no es un diagnóstico.
- Sin ensayos guiados por fenotipo, el beneficio de "fenotipar" aún no está probado.

8 Referencias

1. Fitzcharles M-A, Deamo Assis R, Polly DW, Cohen SP. Mixed pain phenotypes in musculoskeletal disorders: mechanisms and management. *Nat Rev Rheumatol*. 2026. doi:10.1038/s41584-026-01443-w
2. Williams DA, Clauw DJ. Fibromyalgia. *N Engl J Med*. 2026;395:267-77. doi:10.1056/NEJMcp2411656

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico. Ficha relacionada: Fibromialgia, en medicinaenresumen.com.